cuidelo

PROPOSTA PARA VACARIA · RIO GRANDE DO SUL

Toda a rede. Mais perto das pessoas.

Uma plataforma para conectar o acolhimento, o cuidado e a gestão da saúde pública.

CUIDELO / SAÚDE PÚBLICA CONECTADA

Da unidade de saúde ao dia a dia do cidadão.

A proposta reúne UBS, postos, UPA, pronto atendimento, hospitais e gestão municipal em uma jornada contínua. O foco é apoiar as equipes e dar à prefeitura visibilidade para decidir.

ACESSO

Organizar a chegada e os encaminhamentos.

CONTINUIDADE

Acompanhar o cuidado depois da consulta.

GESTÃO

Transformar registros em decisões para a rede.

Versão demonstrativa revisada em 04/11/2026. Dados fictícios.
A implantação operacional depende de validação técnica e assistencial.

01 / A JORNADA DO CUIDADO

Acolher melhor. Acompanhar cada etapa.

Vacaria adotou o acolhimento nas unidades em julho de 2026 [1]. O Cuidelo pode apoiar essa direção com escuta, encaminhamento e visibilidade do percurso de cada pessoa.

01 — Chegada e identificação

Totem por etapas ou recepção assistida. CPF ou nome, serviço e preferência.

02 — Escuta da equipe

Registro de sinais e avaliação profissional. A senha organiza a chamada; não define o risco clínico.

03 — Consulta e prontuário

Chamada pela estação, registro do atendimento e emissão de documentos demonstrativos.

04 — Cuidado encaminhado

Enfermagem, vacinação, exames e regulação acompanham o destino indicado pela equipe.

05 — Entrega de medicamentos

Conferência da receita, entrega total ou parcial e baixa rastreada por lote.

06 — Continuidade em casa

Agenda, documentos, diário e orientações no app do cidadão.

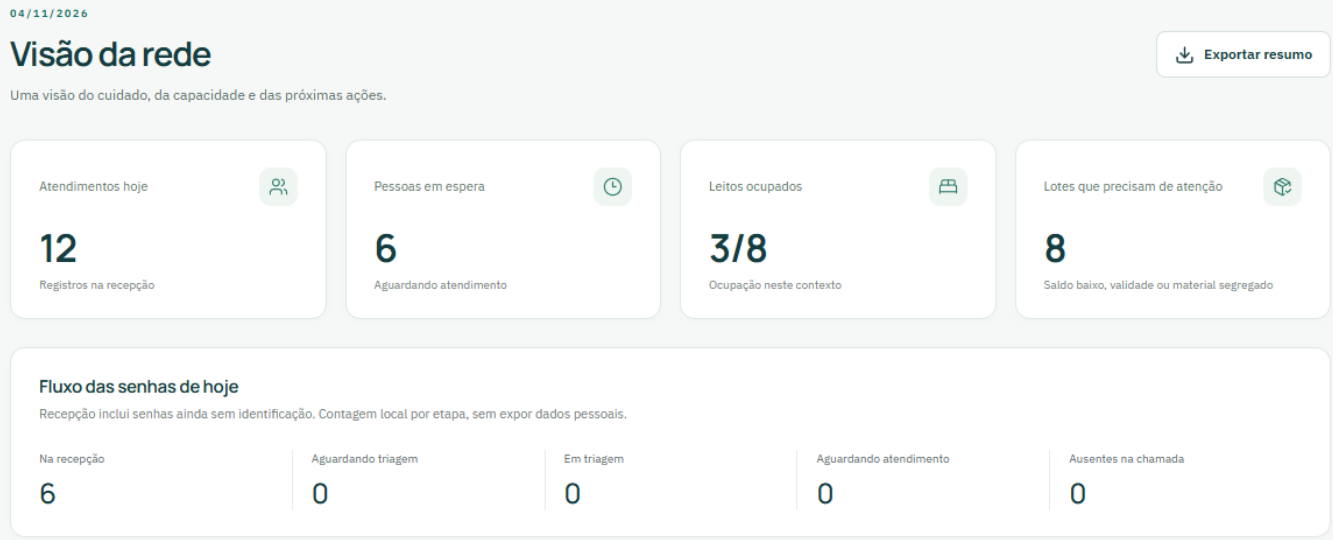


Recepção do Cuidelo. Tela real da demonstração, com dados fictícios.

02 / RESULTADOS PARA A GESTÃO

Ver a rede.
Agir onde faz diferença.

A prefeitura acompanha a rede; a administração local acompanha sua unidade. A visão gerencial trabalha com informações agregadas, mantendo o prontuário no contexto assistencial.



Visão da rede com dados fictícios. As contagens atuais são locais à demonstração.

RESULTADO PRETENDIDO	COMO AVALIAR COM O MUNICÍPIO
Menor espera e melhor fluxo	Tempo por etapa e espera por unidade, com a quantidade de atendimentos medidos.
Maior continuidade do cuidado	Faltas, retornos pendentes e orientações lidas. Confirmação de dose é informada pela pessoa.
Mais rastreabilidade na farmácia	Saldo por lote, entregas parciais, material segregado e remessas em trânsito.
Decisões com contexto	Comparação por período e serviço, considerando demanda, complexidade e equipe disponível.

Os benefícios são objetivos a medir. Ainda não há resultados reais de Vacaria, economia comprovada ou capacidade validada para 100 unidades.

03 / PROPOSTA DE VALOR

O cuidado continua depois da consulta.

O diferencial proposto é conectar o trabalho da unidade ao acompanhamento cotidiano do cidadão.

01 Documentos perto da pessoa

Agendamentos, receitas, pedidos de exames e atestados acessíveis no celular.

02 Acompanhamento cotidiano

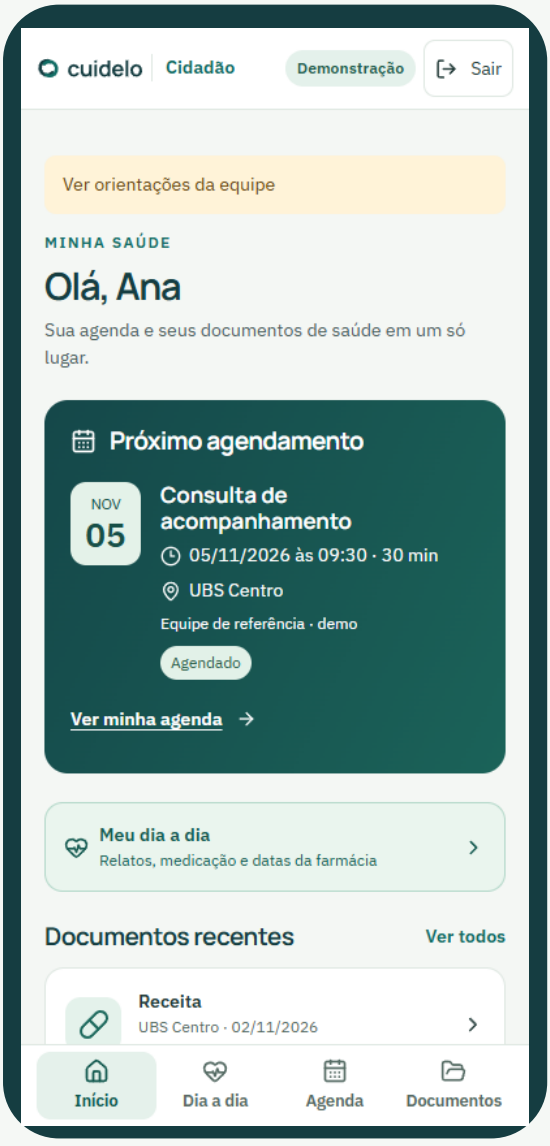
Diário de crises e sintomas, doses tomadas, adiamentos, retiradas e renovações.

03 Retorno ao profissional

A pessoa compartilha o relatório. O médico registra a revisão e envia orientações.

04 Um ciclo de comunicação

Aviso no aparelho, abertura da orientação e confirmação de leitura no consultório.



Tela do app com exemplo fictício.

Conexão além do consultório · TV em outro equipamento, remessa com recebimento parcial na UBS e compartilhamento com o cidadão já podem ser demonstrados. Avisos dependem da autorização e compatibilidade do aparelho.

04 / MATURIDADE E IMPLANTAÇÃO

Uma base demonstrável. Um escopo público completo.

A revisão cobre o catálogo original e os fluxos acrescentados. Há jornadas demonstráveis, módulos parciais e dependências para a primeira operação real.

Atendimento e continuidade	Recepção, escuta, consultório, documentos, vacinação, exames e regulação têm fluxos de demonstração.
Farmácia e logística	Entrega, devolução, estorno e estoque por lote. Remessa por código entre computadores com entrada parcial.
Cidadão e comunicação	Agenda, documentos, Dia a dia, relatórios e orientações. Identidade autenticada e responsáveis ainda pendentes.
Hospital e especialidades	Leitos e observação têm base local. UTI, centro cirúrgico, maternidade, odontologia e CAPS exigem desenvolvimento.
Integrações oficiais	e-SUS APS, RNDS, CNES, assistência farmacêutica, faturamento, diagnóstico e regulação ainda não conectados [2,3].
Proteção e operação	Login individual, permissões no servidor, base clínica protegida, auditoria e recuperação precisam ser implantados.
Escala e disponibilidade	Várias prefeituras e até 100 unidades são o objetivo. Faltam carga, contingência, operação 24/7 e validação em campo.

ANTES DA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL

Conclusão e aceite de todos os módulos previstos, integrações validadas, proteção dos dados e contingência testada. A demonstração pública permanece restrita a dados fictícios.

05 / PRÓXIMO PASSO COM VACARIA

Da demonstração a um projeto pactuado.

Proposta para esta reunião: abrir uma avaliação técnica com a Secretaria de Saúde, TI e representantes das equipes para transformar as prioridades do município em critérios de entrega.

01

Conhecer a rede atual

Mapear serviços, sistemas contratados, conectividade, equipamentos, dados e prioridades das equipes.

02

Validar os percursos

Conferir acolhimento, consulta, farmácia, cidadão, UPA e hospital em homologação com dados fictícios.

03

Fechar o plano de implantação

Definir integrações, migração, segurança, suporte, responsabilidades, orçamento e cronograma.

04

Comprovar antes de operar

Registrar evidências de aceite de todo o escopo, restauração de backup, contingência e testes de capacidade.

Conheça a demonstração

cuidelo.vercel.app/apresentacao

Roteiro guiado e acessos por perfil. Dados fictícios.

REFERÊNCIAS E BASE DA APRESENTAÇÃO

[1] Prefeitura de Vacaria · Balanço do acolhimento nas unidades · 03/09/2026.

[2] Ministério da Saúde · RNDS, plataforma oficial de interoperabilidade.

[3] Ministério da Saúde · API de transmissão LEDI para o e-SUS APS.

Fontes consultadas em 04/11/2026. Telas do Cuidelo e revisão do código desta entrega.
Material para discussão institucional; prazo e investimento serão definidos após o diagnóstico.